

+ 外来患者指導シリーズ第25弾

インフルエンザ・新型コロナ の 予防と家庭療養

「検査で名前がついた後」に、
外来で何を話すか



医知創造ラボ

監修：今村久司（脳神経内科・総合内科専門医）

「熱が下がった」で 終わらせない

結論

検査は陽性ならほぼ本物、休む期間はAND条件、
証明書は不要——この3つで外来が変わります

本日のアジェンダ

1

見分けと検査

症状では判別できない理由と、検査の限界

2

薬と家での過ごし方

抗ウイルス薬の時間窓と、家庭療養の実務

3

休む期間と家庭内感染

法令のAND条件、証明書、家庭内対策のタイミング

CHAPTER

第1章

見分けと検査

症状では、 インフルとコロナを見分けられない

67件のシステマティックレビュー・メタ解析（各119～155,866例）が、個々の症状の精度を検討しました。

- ✓ 発熱の有無0.32・医師の総合的印象0.28・鼻汁0.25——いずれもYouden Indexは0.3前後
- ✓ 陽性尤度比が2.0を超えたのは「医師の総合的な臨床的印象」のみ
- ✓ 咳の感度は0.92と高いが、それだけでは決め手にならない

📋 外来トーク例

「熱の高さや関節痛だけでは、インフルかコロナかは決まりません」

陽性はほぼ本物。 陰性は否定できない

検査	感度	特異度
インフル迅速抗原（RIDT）	A型54.4%／B型53.2%	98%超
インフル デジタル免疫測定	A型80.0%／B型76.8%	98%超
コロナ抗原（有症状者）	73.0%（発症1週目80.9%）	99.1%

外来トーク例

「陰性でも、**感染を完全には否定できません**」

同じレビューでも、 対象が違えば数字が変わる

新型コロナ抗原検査の感度は、対象集団によって数字が変わります。

- ✓ 有症状者が対象の版：感度**73.0%**（発症1週目は80.9%）
- ✓ 無症状者が対象の版：感度**55.0%**（スクリーニング目的ではさらに低下）
- ✓ 55.0%は**無症状者向けの数字**——症状がある人の感度として使わない

⚠ 引用上の注意

「抗原検査の感度は55%」と**一括りにしない**——症状の有無で対象集団が別

CHAPTER

第2章

薬と家での過ごし方

早いほうがよいが、 全員に必須ではない

抗ウイルス薬は、飲む目的と使えるタイミングを分けて説明します。

- ✓ 重症化リスクが高い方以外は**重症化予防効果は限定的**（厚労省Q7）
- ✓ 時間窓は薬ごとに違う——**インフル48時間・ラゲブリオ／パキロビッド5日・ゾコーバ3日**
（発症からの日数）
- ✓ 48時間を過ぎても、**症状が遷延する場合は投与を考慮する**（日本小児科学会）

📋 外来トーク例

「全員に必須の薬ではありません。飲むなら早いほうが効果的です」

「89%減る」という数字は、 誰のデータですか

パキロビッドのEPIC-HR試験（2,246例）の結果です。

- ✓ 対象は**症候性・ワクチン未接種・重症化ハイリスク**の非入院成人
- ✓ 発症3日以内治療で入院・死亡が**0.77% vs 7.01%**（相対リスク減少89.1%）
- ✓ 13例の死亡は**すべてプラセボ群**

⚠ 引用上の注意

現在の一般外来患者に**そのまま「89%減る」と当てはめない**

特別な指示は、 実は多くありません

厚労省ARI Q&Aが示す家庭療養の基本は、実はシンプルです。

- ✓ 安静にして、睡眠を十分にとる
- ✓ 水分補給はお茶でもスープでも、飲みたいもので構わない
- ✓ 2歳未満はマスク着用を勧めない——窒息・熱中症のリスク

📋 外来トーク例

「NSAIDsが危険か安全かは分かっていません。日本ではアセトアミノフェンが第一選択として使われることが多いです」

CHAPTER

第3章

休む期間と家庭内感染

休む期間は、 「発症後」 + 「解熱後」 のAND条件

対象	発症後	+ 解熱・症状軽快後
学校・インフル	5日経過	解熱後2日（幼児3日）
学校・コロナ	5日経過	症状軽快後1日
保育所・インフル	5日経過	解熱後3日（乳幼児）
保育所・コロナ	5日経過	症状軽快後1日
大人（目安）	発症日を0日目に5日間は外出を控える（法令上の日数規定なし）	

外来トーク例

「熱が下がっただけでは足りません。**両方がそろって初めて条件を満たします**」（ただし書きあり——学校医が感染のおそれなしと判断すれば日数によらず登校可）

治癒証明書・陰性証明書は 不要です

厚労省ARI Q&A・保育所ガイドラインが、いずれも明記しています。

- ✓ **職場**：治癒証明書・陰性証明書の提出は不要（厚労省Q20）
- ✓ **学校**：改めて検査を受ける必要はなく、証明書提出は不要（厚労省Q21）
- ✓ **保育所**：検査陰性証明書の提出を求める必要はない（こども家庭庁GL）

📋 外来トーク例

「証明書は**本来不要**です。国もそう明記しています」

対策をするなら、 発症から36時間以内

ドイツのクラスターRCT（84世帯）が、開始タイミングの重要性を示しました。

- ✓ 全体（ITT解析）では**有意差なし**
- ✓ **発症から36時間以内に開始した世帯だけ**、二次感染が有意に低下（調整オッズ比0.16）
- ✓ 発端者の発症から次の家族が発症するまでは、**およそ3日**（Tsang 2016）

📋 外来トーク例

「3日目から部屋を分けても、効果は期待しにくいということです」

異常行動は、 薬のせいとは限りません

厚労省ARI Q&Aは、因果関係が不明であることを明記しています。

- ✓ 服用していない場合でも、同様の異常行動が現れる
- ✓ 服用した薬の種類に関係なく、異常行動が現れる
- ✓ 重度の異常行動は発熱から2日間以内に発現することが多い

📋 外来トーク例

「薬の有無にかかわらず、**発熱から少なくとも2日間**は目を離さないでください」（施錠・1階で寝かせる 等）

こんなときは、 様子見の対象にしない

⚠️ ① 高熱・呼吸苦

意識障害があれば早めに受診

⚠️ ② 高齢者・基礎疾患

妊婦も含め早めに相談を

⚠️ ③ 小児の異常行動

発熱後2日は要注意

⚠️ ④ 咳・熱が長引く

肺炎を疑う場合は精査を検討

📋 症状が軽いうちに、次に受診すべきサインを伝えておく

今日の3つの持ち帰りポイント

01

**陽性はほぼ本物
陰性は否定できない**

症状だけでは、
インフルとコロナを
見分けられない

02

**休む期間は
AND条件**

証明書は不要。大人には
法令上の日数規定なし

03

**対策は
発症36時間以内**

薬は早いほうがよいが、全員に
必須ではない



ご視聴にあたってのお願い

この動画は**一般的な情報提供**であり、
診断・治療の代わりにはなりません。
症状がある場合は**医療機関を受診**してください。

制度・法令・診断精度

[1] 厚生労働省 令和7年度 ARI総合対策Q&A

[3] こども家庭庁 保育所感染症対策ガイドライン

[5] Merckx 2017 (迅速抗原検査精度・Ann Intern Med)

[7] Dinnes 2025 (コロナ抗原・無症状者・Cochrane)

[2] 学校保健安全法施行規則 第19条 (e-Gov)

[4] Ebell 2025 (症状の診断精度・BMJ Open)

[6] Dinnes 2022 (コロナ抗原・有症状者・Cochrane)

抗ウイルス薬・家庭内感染

[8] Dobson 2015 (オセルタミビル メタ解析・Lancet)

[10] Hammond 2022 (EPIC-HR試験・NEJM)

[12] Suess 2012 (家庭内マスク・手指衛生・BMC Infect Dis)

[14] von Philipsborn 2020 (NSAIDsの安全性・BMJ Open)

[9] Hayden 2018 (バロキサビル・NEJM)

[11] Yotsuyanagi 2024 (エンシトレルビル・JAMA Netw Open)

[13] Tsang 2016 (家庭内伝播・Trends Microbiol)

まず、検査と休む条件から



詳しい解説は
ブログへ

概要欄から
ブログ記事を
ご覧ください



患者配布用ハンドアウト

外来でそのまま使える
配布資料を用意しています



高評価・
チャンネル登録

次回も
お楽しみに

最後までご視聴いただきありがとうございました。
役に立ったと感じたら、高評価とチャンネル登録を
いただけると励みになります。